

Los trastornos alimentarios (TCA) son condiciones de salud mental con una de las tasas de mortalidad más altas dentro de la psicopatología. No son una elección, una fase ni el resultado de una dieta que salió mal: son formas complejas de sufrimiento que afectan la relación con la comida, el cuerpo y las emociones — y tienen tratamiento con evidencia sólida.

Los tipos más frecuentes

Anorexia nerviosa. Restricción severa de la ingesta, miedo intenso a la ganancia de peso y alteración en la percepción del cuerpo. El peso puede ser bajo, pero no siempre: existen presentaciones con peso normal (“anorexia atípica”) igualmente graves.

Bulimia nerviosa. Episodios recurrentes de ingesta descontrolada seguidos de conductas compensatorias (vómitos autoprovocados, ayuno, ejercicio compulsivo o uso de laxantes). La mayoría de las personas con bulimia presenta peso normal, lo que dificulta su detección.

Trastorno por Atracón (TA). Episodios recurrentes de ingesta descontrolada sin conductas compensatorias, acompañados de malestar emocional intenso. Es el TCA más frecuente en población general y se presenta en personas de todos los tamaños corporales.

ARFID. Restricción o evitación alimentaria no motivada por preocupaciones sobre el cuerpo o el peso, sino por características sensoriales, miedo a atragantarse o bajo interés en la comida. Afecta especialmente a niños y adolescentes.

Otros TCA especificados. Cuadros que no cumplen todos los criterios de las categorías anteriores pero generan sufrimiento real e impactan la calidad de vida. Requieren la misma atención profesional.

¿Por qué ocurren?

Los TCA tienen una etiología multifactorial: ningún factor aislado los explica. Lo que sabemos es que existe una interacción entre predisposición biológica (la heredabilidad se estima entre 50–80% para la anorexia nerviosa), factores psicológicos —perfeccionismo, dificultades en regulación emocional, baja tolerancia al malestar— y factores socioculturales como la presión hacia la delgadez y el estigma del peso. Los eventos precipitantes —transiciones vitales, pérdidas, traumas, inicio de dietas en personas con predisposición— pueden activar esa vulnerabilidad preexistente.

No los causa la falta de voluntad, la vanidad, “llamar la atención” ni la superficialidad. Tampoco se explican por un sólo factor familiar, aunque el contexto vincular forma parte del abordaje terapéutico.

■ La recuperación es posible. El pronóstico mejora significativamente con diagnóstico temprano y tratamiento especializado. Si te reconocés en lo que describe esta ficha, el primer paso es consultar con un profesional de salud mental con formación en TCA.